EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 84362
SERVICIO : MEL MUJERES HSC
FECHA : 2024-05-12 14:02:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: MARIA ELENA VI►AS LUEIZA			RUN	: 8.796.695-K
F.Nac	: 14-07-2023	Edad	: 0 AÑO, 9 MESES	Género	: Femenino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-05-09	Fecha Egreso	: 2024-05-12 14:02:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DOMICILIO	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J44.9-ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Insuficiencia respiratoria aguda:
-Neumonía bibasal
- EPOC GOLD D exacerbado | Usuaria O2 domiciliario
Obesidad
HTA

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J96.0-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente Femenina De 65 Años Con Antecedentes Mórbidos De Epoc Gold D, , Tabaco + Biomasa (Aun Expuesta) Usuaria De Oxigeno Domiciliario, Hipertensión Arterial, Obesidad, Prolapso Genital En Tto Fármacos Salmeterol 2 Puff Cada 12 Horas Permanente -Ipratropio 4 Puff Cada 6 Horas Permanente -Salbutamol 2 Puff Sos. -Losartan 50mg Cada 12 Horas Permanente -Furosemida 1/2 En La Mañana.
Acude Al Servicio De Urgencia Por Presentar Aumento De Su Disnea Basal, Concomitante Tos , Con Expectoración, Compromiso Del Estado General. Se realiza exámenes de laboratorio que destacan Glicemia : 216 * mg/dl Albumina : 3,5 g/dL Creatinina : 0,50 * mg/dl CK MB : 27 * U/L CK : 22 * U/L LDH : 233 U/L Clearence Calculado(MDRD) : 123,83 Lactato : 1,3 Proteina C Reactiva : 175,7 Troponina : 135,2 control Troponina : 212,3. Se ingresa para comperzar exacerbacion de epoc y tto depletivo .

Durante estancia en servicio de medicina recibiendo tratamiento ATB con ceftriaxona con buena respuesta clínica, disminución de requerimiento de O2 (Actualmente con 1lt por NRC), función renal sin compromiso, sin cambios que sugieran descompensación desde el punto de vista cardiaco.
En vista de condiciones y buena respuesta se decide derivar a HODOM para continuidad de atención.

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo
2. Regimen hiposódico, diabético a tolerancia

3. O2 domiciliario
4. Omeprazol 20mg vo día
5. Ceftriaxona 2 G Ev Cada 24 Horas (4/7)
6. Aspirina 100 Mg Dia Vía Oral
7. Atorvastatina 80 Mg Noche Vía Oral
8. Omeprazol 40 Mg Ev Día
9. Clopidogrel 75 Mg Oral Día
10. B.Ipatropio 4 Puff C/6 Hrs
11. Salbutamol 2puff Cada 6 Horas
12. Prednisona 20mg vo c8h por 3 días, luego c12h por 2 días, luego c24h por 2 días
13. Brexotide 2 puff c12h
14. Quetiapina 25 X Noche
15. Losartan 50mg C/12 Hrs
16. KNT diario
17. Derivo para continuidad HODOM

andres david velasquez guerra
MEDICO TRATANTE
27124399-5

JEFE SERVICIO